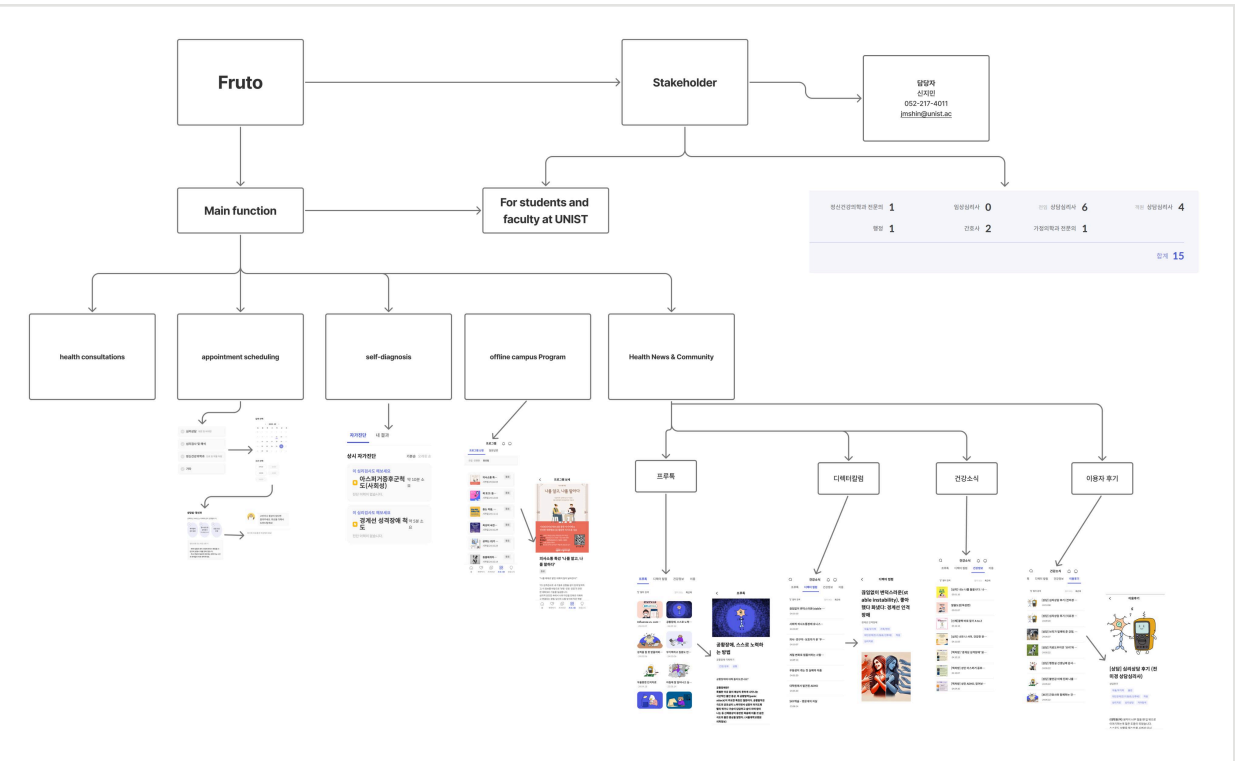
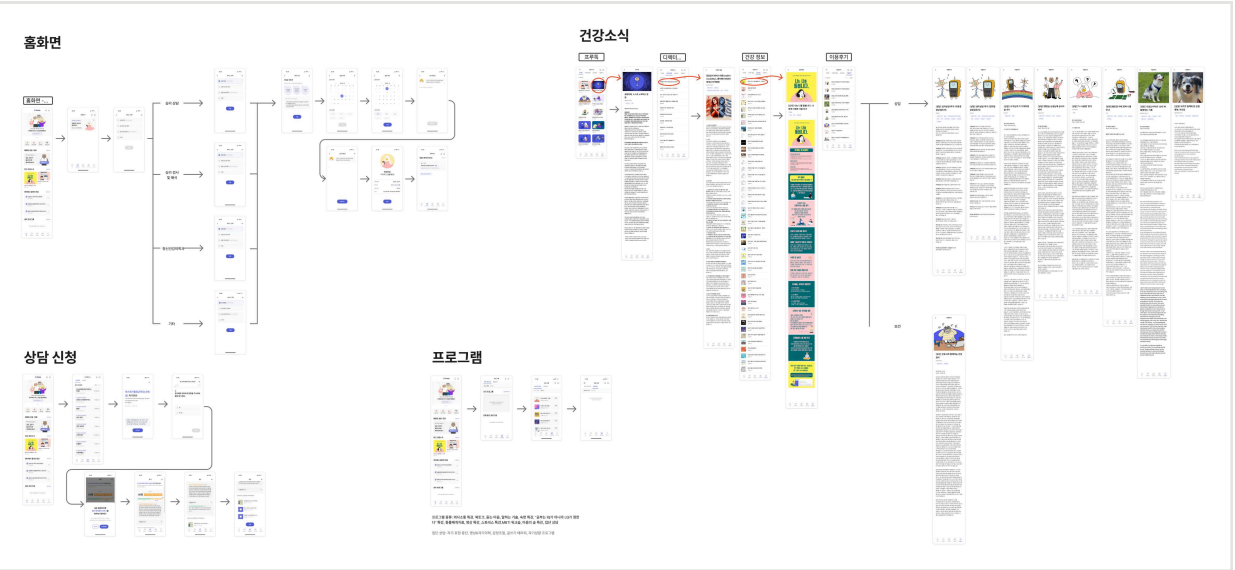


UNIST 정신건강 향상을 위한 서비스 재디자인

팀	COUNCY (김은후, 문준영, 최지예, 천호진)
목표	자살 위험이 높은 대학생 고위험군이 UNIST 정신건강 서비스에서 제때 치료를 받지 못하는 구조적 문제를 서비스 디자인 관점에서 재구조화
접근법	1차 리서치 → 2차 리서치 → 문제 정의 → 최종 솔루션

Desk research



우리 팀은 UNIST 구성원의 정신건강 향상을 위한 기반을 마련하기 위해, 현재 제공되고 있는 정신건강 서비스의 구조와 방향을 분석하는 배경조사(Background Research)를 진행했다.

UNIST 정신건강 서비스 중 가장 널리 알려진 플랫폼인 프루토를 우선적으로 데스크 리서치 대상으로 선정하였다.

살펴본 결과 프루토는 건강상담, 상담 예약, 자가진단, 오프라인 프로그램 안내, 건강소식 및 커뮤니티 5가지 기능을 제공하는 걸 확인했다.



국내 주요 대학의 정신건강 서비스 사례를 비교 분석하였다.

건국대학교, 울산대학교, 부산대학교, 서울대학교, KAIST, 연세대학교의 헬스케어센터를 조사한 결과, 이들 서비스는 다음의 네 가지 기능적 영역으로 구분할 수 있었다.

사전/예방 영역: 문제가 발생하기 전에 미리 점검하고 관리하는 서비스

관계/프로그램 영역: 사람 간의 관계를 통해 정서적 회복을 돕는 서비스

치료 영역: 전문 상담이 개입되는 치료 중심의 서비스

지속성 장치: 사용자가 서비스를 반복적으로 이용하도록 유도하는 장치

프루토는 이처럼 다양한 기능을 제공하지만, 네 가지 영역 중 ‘또래상담 서비스’, ‘내담자 사전·사후 관리’, ‘지속성을 높이는 장치’는 여전히 부족한 것으로 나타났다. 따라서 본 연구에서는 프루토의 개발 과정을 보다 깊이 이해하기 위해 프루토 개발자 인터뷰를 수행했다.

Desk research 코멘트

— 초기 문제정의 없이 시작한 재디자인의 어려움

“UNIST의 정신건강 서비스는 국내 대학 중 비교적 체계적으로 구축되어 있음에도 불구하고, 초기 접수 상담 이후 상담사 배정까지 평균 38일, 최대 91일이 소요되는 긴 대기 시간이 존재한다. 정신건강 고위험군은 예방이 아닌 즉각적인 치료에 접근해야 한다는 점에서, UNIST 정신건강 서비스에서 이러한 대기시간이 발생하는 구조적 이유를 파악하고 도움을 요청한 구성원이 적기에 서비스에 접근할 수 있도록 개선할 필요가 있었다.”

라고 리포트에 적어두었으나, 이는 뒤늦게 발견한 문제점이지 우리가 처음부터 발견한 문제점이 아니었다. 재디자인을 하는 분명한 이유가 존재하지 않았고, 그 뒤로 문제점을 찾아낸 것에 가깝기 때문에 다소 험난한 서비스 재디자인이 진행되었다.

User Study - 개발자 인터뷰

SERVICE DESIGN RETROSPECTIVE — 2026

인터뷰 질문지

서비스 디자인 기초 팀 소개	안녕하세요, 저희는 UNIST 디자인학과 이소호 교수님의 '서비스 디자인 기초' 수업을 수강하는 학생팀입니다. 이번 학기 프로젝트로 UNIST 정신건강 상담 서비스인 'Fruto'의 사용자 경험 계산을 위한 서비스 재디자인을 진행하고 있습니다. 현재까지 데스크 리서치를 통해 Fruto의 전반적인 서비스에 대해 파악했으며, 실제 개발 과정에서의 실제 의도와 현황을 이해하고자 이번 인터뷰를 요청드립니다.
인터뷰 목적	이번 인터뷰의 목적은 Fruto를 실제로 개발하신 분의 관점에서 서비스의 실제 의도와 현재 운영 상황을 이해하기 위함입니다. 개발 과정에서 어떤 목표를 가지고 어떤 고민을 하셨는지, 그리고 현재 서비스가 당초 목적에 맞게 잘 운영되고 있는지에 대한 개발자의 솔직한 의견을 듣고 싶습니다.
Focus	Questions
기본정보	먼저 간단한 자기소개를 부탁드립니다. 어떤 역할로 프루토 개발에 참여하게 되었나요? 프루토 프로젝트에서 주로 어떤 업무를 담당하셨는지 궁금합니다.
Fruto의 Identity	프루토를 만들게 된 계기는 무엇인가요? ↳ 기존 UNIST 정신건강 서비스에서 어떤 문제점을 발견하셨나요? 프루토가 제공하고자 한 핵심 기능이나 가치는 무엇인가요? 프루토에서 '개인상담 예약, 자가진단, 건강소식' 이 3가지 서비스를 우선적으로 선택한 특별한 이유가 있나요? ↳ 다른 대학이나 상담 기관의 서비스를 참고하거나 벤치마킹해보신 적이 있나요?
서비스 현황에 대한 평가	현재 프루토의 서비스가 내담자들에게 능동적 작동하고 있다고 생각하시나요? 아니면 수동적으로 작동하고 있다고 생각하시나요? ↳ 능동적이라면, 처음 기대했던 것과 비교해서 현재 ↳ 수동적이라면, 처음 기대와 다르게 현재 프루토가 프루토가 어느 정도 역할을 하고 있다고 생각하시나요? 어느 정도 역할을 하고 있다고 생각하시나요?
사용자 중심 개발 과정	프루토를 개발하면서 실제 사용자(학생들)의 니즈를 파악하기 위한 리서치를 진행해보신 적이 있나요? ↳ 만약 진행하셨다면, 어떤 방법으로 사용자의 의견을 수집하셨나요? ↳ 리서치 과정에서 개발팀이 예상하지 못했던 사용자 니즈를 발견한 적이 있나요? 사용자 리서치 결과가 실제 프루토 개발에 어떻게 반영되었나요?
프루토를 개발 도중에 느낀 어려움 및 고려사항	프루토를 개발하면서 느낀 어려움이나 한계는 무엇이었나요? ↳ 정신건강 서비스라는 민감한 영역에서 개발할 때 특별히 고려해야 했던 점들이 있나요? ↳ 프루토를 개발하면서 정신 건강의 의학적인 지식은 어떻게, 어디까지 공부하셨나요? ↳ 정신 건강의 의학적 전문성을 갖추기 위해 협업한 기관이 있었나요? 개발하면서 초기 설계나 기획이 바뀐 적이 있나요? ↳ 만약 변경이 있었다면, 어떤 이유로 변경하게 되었나요? ↳ 만약 계획이 크게 변경이 없었다면, 어떤 초기 설계를 세우셨나요? 헬스케어센터와는 어떤 방식으로 협업을 진행하셨나요? ↳ 개발팀과 헬스케어센터 간에 의견 차이나 조율이 필요했던 부분이 있었나요? (니즈 파악)
앞으로 프루토의 개선 방향	개발자 관점에서 현재 프루토에서 가장 개선이 필요한 부분은 무엇이라고 생각하시나요? 프루토 서비스를 UNIST를 넘어 다른 대학이나 기관으로 확장할 계획이 있나요?

프루토 개발자 인터뷰는 2022년부터 프루토를 연구 진행한 HAI LAB의 개발자와 OND 개발자를 반구조화된 인터뷰 질문지와 함께 약 1시간 내외로 인터뷰를 진행했다.

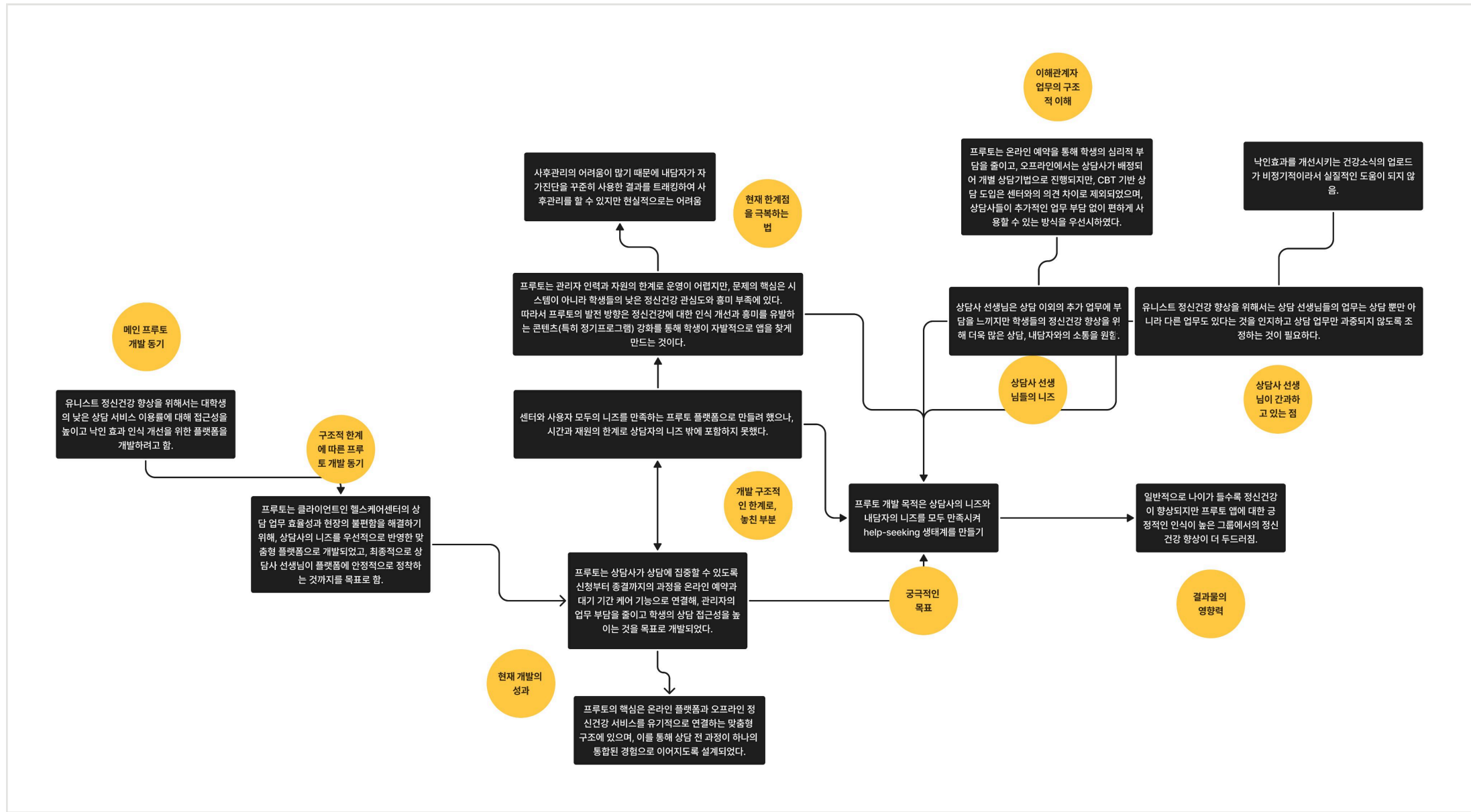
인터뷰에서는 크게 3가지를 물어보려고 했다.

프루토의 정체성에 따라 어떤 기능이 우선적으로 개발되었는가
사용자 중심 설계(User-centered design)가 어느 정도 반영되었는가
개발 과정에서 발생한 구조적 어려움과 한계는 무엇인가

개발자 인터뷰를 진행한 이후 Affinity Diagram을 통해 핵심 인사이트를 분석한 결과 유니스트 정신건강 서비스에 헬스케어 센터가 main stakeholder라는 것을 인지하였다
이를 통해 헬스케어센터 인터뷰를 진행했다.

User Study - 개발자 핵심 인사이트

SERVICE DESIGN RETROSPECTIVE — 2026



개발자

개발자의 목표

프루토의 개발은 유니스트 학생들의 낮은 상담 서비스 이용률을 개선하고, 정신건강에 대한 낙인 인식을 완화하기 위해 개발되었다. 프루토의 궁극적인 목표는 학생이 스스로 정신건강을 인식하고 필요 시 주도적으로 도움을 요청할 수 있는 help-seeking 생태계를 조성하는 것이다.

실제 개발 진행 순서

그러나 초기 개발 과정에서 프루토의 직접적인 클라이언트는 헬스케어센터였기 때문에, 개발팀은 우선적으로 센터의 요구를 반영하여 상담사들이 내담자 정보를 보다 체계적으로 관리하고, 상담 과정을 효율화할 수 있는 관리자 중심의 플랫폼을 구축했다. 따라서 개발 초기 단계의 핵심 목표는 상담사가 상담에만 집중할 수 있도록 행정적 업무를 줄이고, 상담 신청·배정·기록 등의 절차를 표준화하는 것이었다. 이런 이유로 프루토는 ‘관리자용 맞춤형 시스템’으로 출발했고, 상담 폼 통일화와 온라인 예약 기능이 먼저 개발되었다. 그 결과 학생 입장에서 긍정적 변화를 일부 가져왔다. 온라인 예약 절차를 통해 상담 신청에 대한 심리적 부담이 완화되었고, 상담사들의 여유 시간 증가로 오프라인 상담으로 이어지는 경험이 보다 체계적으로 구성되었다.

개발자가 발견한 헬스케어센터의 서비스 구조적인 문제

헬스케어센터 상담사의 주요 업무는 고위험군 내담자의 상담에 집중되는 만큼, 시간적 여유가 어느정도 생겨도 콘텐츠 개발은 현실적으로 큰 부담으로 작용했다. 이로 인해 **개발자가 기대한 help-seeking 문화 확산에는 구조적 한계가 발생했다.**

User Study - 헬스케어센터

SERVICE DESIGN RETROSPECTIVE — 2026

헬스케어센터 질문지

Focus	Questions	
Purpose of interview	이번 인터뷰는 유니스트 정신건강을 향상시키기 위해 헬스케어센터 상담사 선생님들의 근무 방식과 현재 운영 상황을 이해하기 위함입니다. 인터뷰 내용은 익명으로 기록되며 내부 자료로만 활용됩니다. 인터뷰 중 녹음하는 것에 동의하시나요?	
Ice breaking	상담사분의 성함, 헬스케어센터 경력, 이전에 근무했던 부서를 포함한 간단한 자기소개 부탁드립니다.	
#1. 헬스케어센터 상담사 선생님의 역할 이해		
상담사의 주요 업무 및 일상적 역할	헬스케어센터에서 선생님은 어떤 업무를 보시나요?	
#2. 유니스트 정신건강 서비스		
정신건강 서비스의 현황	유니스트 정신건강 향상을 위해 헬스케어 서비스가 학생들에게 충분히 제공되고 있다고 생각하시나요?	
Follow-up questions	Option1. 충분히 제공되고 있음	Option2. 충분하지 않음
현재 상담에 대한 판단	상담과 상담기법의 효과에 대해 어떻게 생각하시나요?	
상담기법의 역할	내담자는 상담과 상담기법에 어떤 효과를 보였었나요?	새로운 상담 기법이 도입된다면 어떤 변화가 나타날까요?
새로운 서비스의 기회	상담이외에도 정신건강을 도울 수 있는 방법이 있을까요?	
	다른 학교의 상담 시스템과 유니스트 헬스케어센터의 차이점은 무엇일까요?	
#3. 내담자 상담 프로세스		
첫 상담의 시작	내담자는 어떻게 배분 받으며, 상담을 시작하게 어떤 과정으로 진행 되나요?	
프루토 이용	내담자 상담과정에서 프루토를 어떻게 사용하시나요?	
내담자 관리	상담 진행 후 내담자 관리가 어떻게 진행되나요?	
	내담자 사후 관리는 어떻게 진행하시나요?	
#4. 헬스케어센터의 업무		
프루토의 효과	프루토를 사용함으로써 가장 크게 느껴지는 업무의 변화가 뭔가요? / 불편한 점이 있었나요?	
	프루토에서 제공하는 자가진단이 내담자에게 도움이 되신다고 생각하시나요?	
학생 사전 관리	헬스케어센터에서는 유니스트 구성원의 정신건강을 사전 관리하기 위해 어떤 노력을 하고 계시나요?	

헬스케어센터 질문지	
Focus	Questions
Purpose of interview	이번 인터뷰는 유니스트 정신건강을 향상시키기 위해 헬스케어센터 상담사 선생님들의 근무 방식과 현재 운영 상황을 이해하기 위함입니다. 인터뷰 내용은 익명으로 기록되며 내부 자료로만 활용됩니다. 인터뷰 중 녹음하는 것에 동의하시나요?
Ice breaking	상담사분의 성함, 헬스케어센터 경력, 이전에 근무했던 부서를 포함한 간단한 자기소개 부탁드립니다.
#1. 헬스케어센터의 서비스	
헬스케어 센터의 타겟	현재 서비스가 충분히 도달하지 못한다고 느끼는 우선 타겟(페르소나)이 있다면 누구인가요?
	상담이 필요한 학생이 “너무 드러나 보일까 봐” 주저하는 경우, 어떤 식의 커뮤니케이션(문구, 시각언어, 캠페인)이 효과적일까요?
내담자 관리	헬스케어센터에서는 내담자들과 어떻게 소통하고 계신가요?
#2. 내담자 상담 프로세스	
자가진단 이용 상황과 관찰	자가진단을 통해 위험군이 표시되면 상담 신청까지 이어지는 학생이 꽤 있다고 하셨는데, 반대로 위험군이지만 상담 신청으로 이어지지 않는 경우는 어떤 이유 때문이라 생각하시나요?
상담 중절 피드백	상담 중절 이후 스스로 다시 궤도에 오를 수 있게 도와줄 핵심 도구는 무엇이라고 보시나요?
#3. 프루토의 변화	
프루토에 대한 인식	학생이 프루토를 ‘상담 앱’이 아니라 ‘자기 이해 플랫폼’으로 인식하게 하려면, 어떤 유형의 콘텐츠 가장 적합하다고 보시나요?
#4. 헬스케어센터의 목표	
궁극적인 목표 달성	“학생이 스스로 도움을 찾는 생태계”를 만드는 데 가장 중요한 조건은 무엇이라고 생각하시나요?

헬스케어센터 인터뷰로 넘어간 이유

헬스케어센터가 정신건강 서비스의 핵심 이해관계자님을 깨달았으며 개발자가 바라보는 문제를 헬스케어센터도 똑같이 바라보고 있는지, 치료과정은 어떻게 되며 프루토가 도움이 되고 있는지 알아보고자 인터뷰를 했다.

인터뷰에서는 크게 3가지를 물어보려고 했다.

- 프루토를 현재 상담사가 잘 사용하고 있는가
- 유니스트 정신건강 서비스는 어떻게 운영되는가
- 고위험군을 상담하는 프로세스는 잘 구축되어있는가

헬스케어센터는 헬스케어센터에서 10년 가까이 근무한 두 명의 상담사 분을 인터뷰 했다.

[illegible]

헬스케어센터 상담사의 유니스트 정신건강의 궁극적인 목표는 고위험군 내담자가 치료시기를 놓치지 않고 상담을 받을 수 있는 기회를 제공하는 것이었다.

상담사는 학생을 ‘예방’, ‘발굴’, ‘치료’ 3가지 단계로 나누며 “프루토를 만드는 이유는 자원, 인력의 제한으로 인해 프루토를 통해 정신건강이 향상될 수 있는 사람들이 프루토를 통해 도움을 받고, 정말 심리상담이 필요한 사람들이 헬스케어센터에 방문하게 하기 위함이다.”

헬스케어센터 인터뷰를 통해 발견한 사항은 그들이 **고위험군을 우선적으로 타겟**한다는 것과 이것은 **단순히 치료법의 문제가 아니라 고위험군이 가지고 있는 낙인효과에 따른 접근의 진입장벽과 고위험군이 가진 환경에서의 문제가 더욱 크다**는 것을 발견하였다.

07 / 17

Desk research - 고위험군

고위험군 정의 및 분류 기준 조사

고위험군을 분류하는 과정은 단순히 특정 점수나 단일 증상만으로 판단하기보다, 여러 위험 신호가 어떤 방식으로 함께 나타나는지를 중심으로 살펴보는 방식으로 이루어진다는 것을 확인했다. 이는 고위험군을 정의한 선행 연구(Czyz et al., 2013)가 보여준 중요한 관점을 참고한 것이다. 해당 연구에서는 우울, 자살사고, 충동성, 알코올 문제 등 다양한 위험요인이 어떻게 조합되어 나타나는지를 분석하여, 표본 내부에서 상대적으로 위험 수준이 높은 학생들을 구분하였다. 우리는 단일 점수 기준보다는 여러 위험 신호가 동시에 존재하는 상황을 더 중요하게 고려하고자 했다.

하지만 프로젝트에서는 국가정신건강정보포털과 국가트라우마센터에서 제공하는 표준화된 자가검진 문항을 병행하여 활용하였다. 이 문항들은 우울(PHQ-9 구조), 불안, 조증적 경향, 조현증 스펙트럼 증상(환청·사고전파), 강박, 음주, 수면, 인지 기능 등 주요 정신건강 영역을 폭넓게 다루고 있으며, 자살위험성 항목(자해 충동, 계획, 실행 가능성, 보호요인)은 국내 공공의료체계에 서 실제로 사용되는 임상적 선별 기준을 기반으로 한다.

고위험군 정의 및 분류 기준 세우기

이 프로젝트에서는 먼저 이 표준 검사 문항을 통해 의미 있는 위험 신호가 존재하는지를 확인하였다. 이후, 선행 연구의 관점을 바탕으로 위험요인을 각각 따로 보기보다 어떤 위험 신호들이 함께 나타나는지를 확인하고자 설문 응답뿐 아니라, 학생들이 직접 작성한 주관식 응답 내용도 함께 분석하여 정량·정성 정보를 종합적으로 해석하였다. 그 결과, 다음 두 조건 중 하나라도 충족되면 해당 학생을 잠정적 고위험군으로 분류하는 기준을 세웠다.

자살 관련 문항에서 위험 신호가 확인된 경우

우울·불안·기능 저하·지각 경험 이상 등 주요 증상이 둘 이상 복합적으로 나타난 경우

출처 — Czyz et al., 2013

자가검진 문항 — 국가정신건강정보포털 · 국가트라우마센터

User Study - 고위험군

SERVICE DESIGN RETROSPECTIVE — 2026

당신의 마음은 잘 지내고 있나요?

대학생의 마음 건강, 생활습관, 스트레스 요인에 관한 설문조사입니다.

설문 참여자 중 추천을 통해 소정의 기프티콘을 드립니다.

대상 : UNIST 학부생 및 대학원생 누구나
& 정신적으로 힘들었던 분

모든 응답은 익명으로 처리되며,
연구 외의 목적으로는 사용되지 않습니다.

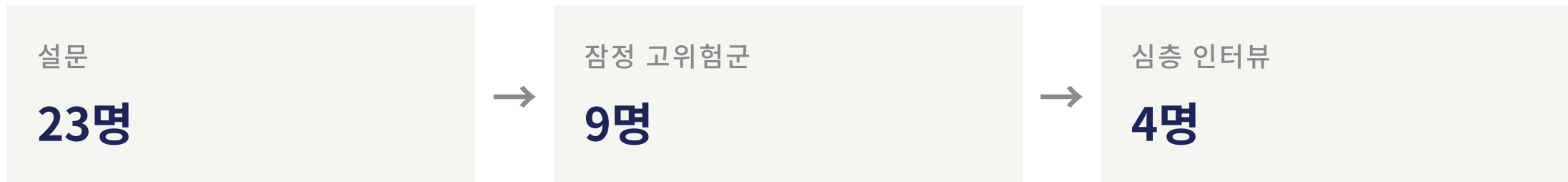
고위험군 질문지

Focus	Questions	
Purpose of interview	이 인터뷰는 정신건강 고위험군이 실제로 상담 서비스에 접근하고 이용하는 과정에서 겪는 어려움과 인식을 이해하기 위함입니다. 인터뷰 내용은 익명으로 기록되며, 연구 목적 외에는 사용되지 않습니다. 인터뷰 중 녹음하는 것에 동의하시나요?	
Ice breaking	최근의 개인적인 이야기나 경험 중에서 정신건강과 관련해 기억에 남는 순간이 있었을까요?	
#1. 상담 경험에 대한 여부		
상담서비스 이용 경험	힘들었던 시기에 정신건강 관련 상담 서비스를 이용해본 적이 있으신가요?	
Follow-up questions	Option1. 받아본 적이 있음.	Option2. 받아본 적이 없음.
상담 서비스의 접근 과정 및 어려움	어떻게 알게 됐나요?	이용하지 않았다면, 그 이유는 무엇인가요?
	상담을 시작하는데 가진 어려움이 있었나요?	
#2. 주변인과 상담 경험 공유		
상담 경험 공유	상담에 대해서 주변인에게 이야기한 적이 있으신가요? (상담에 대한 추천, 경험담 이야기)	
#3. 일상 속에서의 힘든 순간		
힘들을 느끼는 구체적인 장소와 시간	평소 어떠한 시간대와 장소에서 힘들음을 느끼나요?	
	그럴 때 주로 어떤 방식으로 감정을 다루거나 해소하시나요?	
#4. 상담에 대한 인식과 경험		
학생 사전 관리	상담이나 정신건강 서비스에 대해 평소 어떤 이미지나 인식을 갖고 있었나요?	
지속적인 상담 관리	"한 번 상담하고 끝나는 구조"와 "지속적으로 연결되는 구조" 중, 본인은 어떤 쪽이 더 안정감을 줄 것 같나요?	

고위험군 설문조사 결과

설문조사는 익명으로 진행되었으며 총 23명의 응답이 수집되었다. 설문에는 우울(PHQ-9 구조), 불안, 충동성, 강박, 수면, 음주 문제, 지각 경험 이상, 그리고 자살사고·계획·실행 가능성 등 국가 정신건강센터 표준 스크리닝 항목이 포함되어 있었다. 또한 “가장 힘들었던 경험”, “도움 요청의 어려움”, “스트레스 요인과 생활 변화” 등 정성 문항을 통해 응답자의 심리적 어려움의 맥락을 함께 파악하였다.

정량 문항의 임상적 위험 신호와 정성 문항에 드러난 심리·상황적 어려움을 종합 분석한 결과, 23명 중 9명을 잠정적 고위험군으로 분류하였다. 이후 인터뷰 참여에 동의한 4명을 대상으로 약 30분~1시간의 반구조화 인터뷰를 진행하였다.



잠정 고위험군 선별 기준

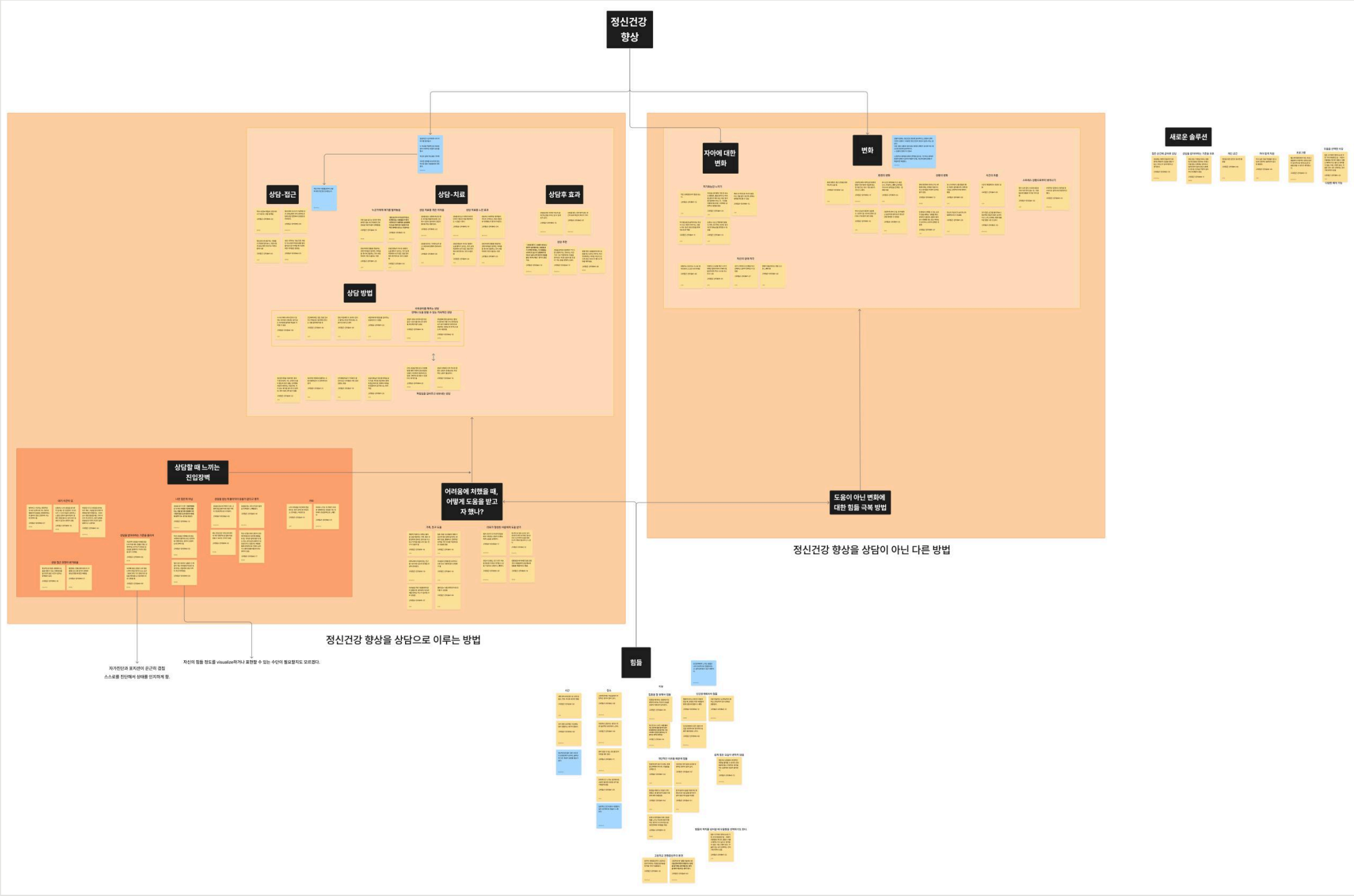
자살 관련 문항에서 위험 신호가 확인된 경우

우울·불안·기능 저하·지각 경험 이상 등 주요 증상이 둘 이상 복합적으로 나타난 경우

고위험군 심층 리서치

인터뷰는 네 가지 주제 ‘① 상담 이용 경험과 접근 과정, ② 주변인과의 상담 경험 공유, ③ 일상 속에서 힘들어 발생하는 구체적 맥락, ④ 상담에 대한 인식과 치료적 기대’를 중심으로 구성되었으며, 고위험군이 상담에 접근하는 과정에서 겪는 경험을 심층적으로 탐색하는 데 초점을 두었다. 인터뷰는 모두 익명으로 대면 진행되었다.

User Study - 고위험군 핵심 인사이트



고위험군의 어려움의 이유

고위험군은 복합적인 요인 속에서 정신적 어려움을 겪고 있으며, 이를 해결하기 위해 세 가지 방식(주변 지지 기반의 도움 요청, 자기효능감 기반 회복, 환경·상황 변화 기반 회복)을 시도하지만 **실행 조건이 제한적이기 때문에** 실제로는 상담이 가장 현실적 이고 접근 가능한 개입으로 자리 잡고 있었다.

상담의 효과

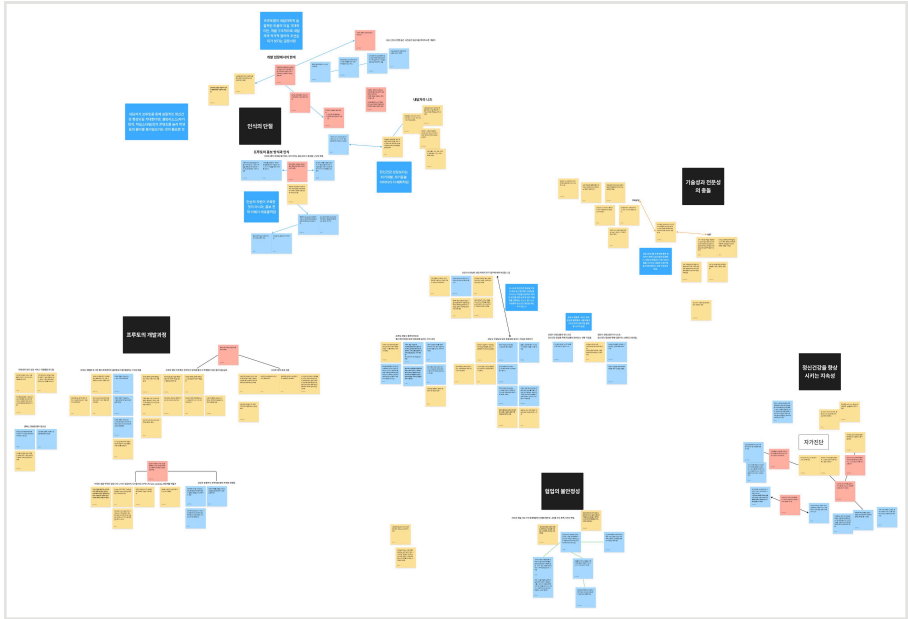
상담을 시작한 이후에는 자신의 이야기를 말하는 과정에서 상황을 객관적으로 바라보고 감정이 정리되며, 삶의 통제력을 다시 확보하는 변화가 나타났다. 이러한 경험은 다시 주변 지인에게 공유되어, 새로운 내담자를 상담 서비스로 유입시키는 순환적 흐름을 형성하였다.

상담 진입의 어려움

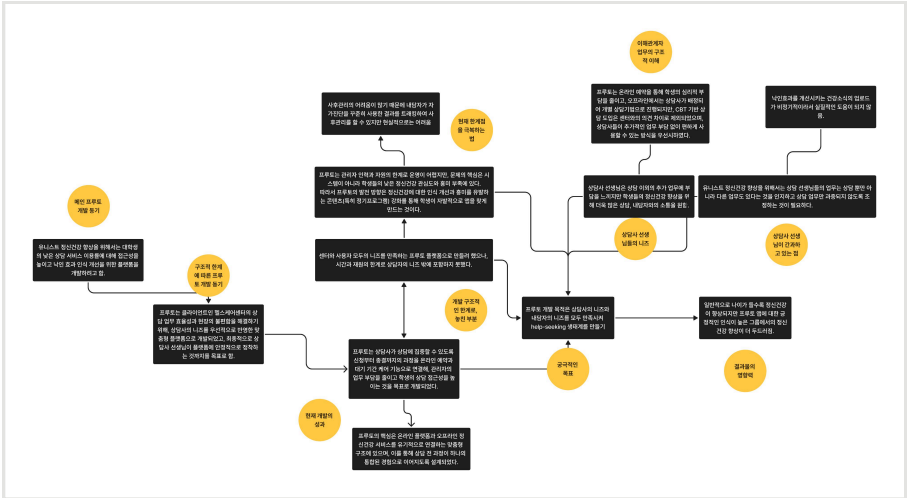
하지만 상담 이용 과정에는 여러 진입장벽이 존재했다. 상담 대기시간의 길이, 복잡한 신청 절차, 상담을 받아야 하는 기준의 모호함, 상담 이용에 따른 불이익 우려, ‘나만 힘든 것이 아니다’라는 인식에서 오는 필요성 축소 등이 반복적으로 등장하였다. 이 중 상담 대기시간을 제외한 대부분의 요소는 구조·경험 개선을 통해 완화 가능한 장벽으로 나타났다.

User Study - 전체 코멘트

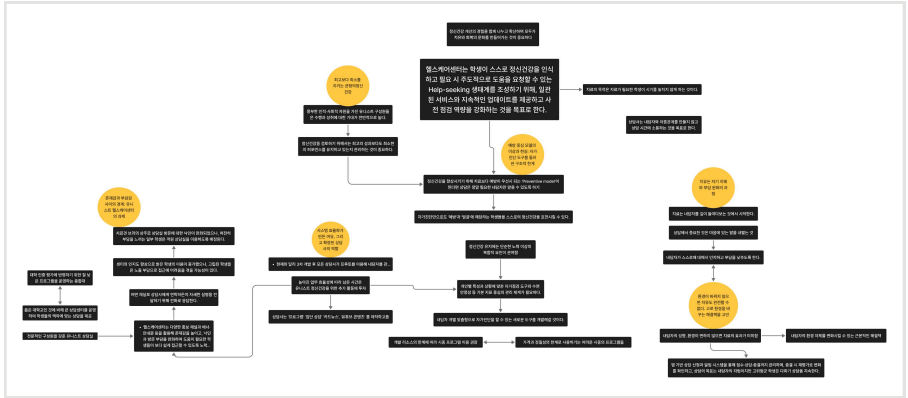
SERVICE DESIGN RETROSPECTIVE — 2026



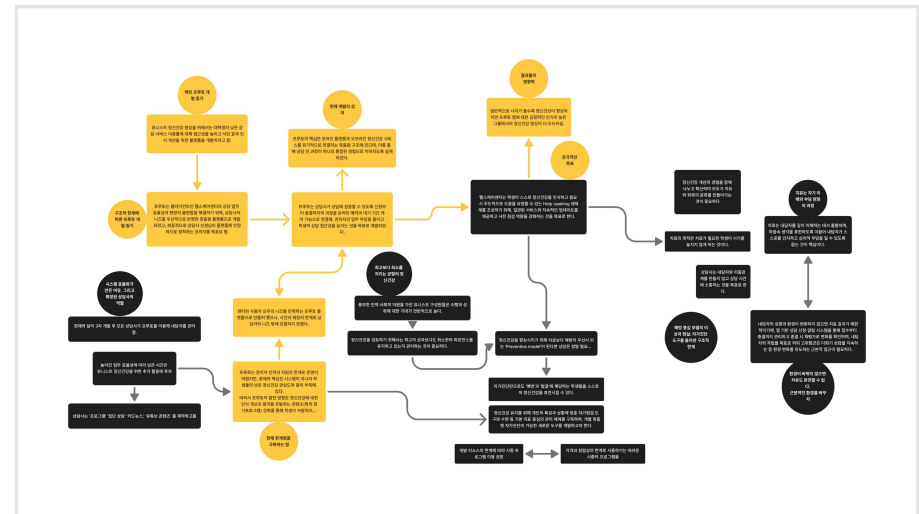
개발자 어피니티 시도



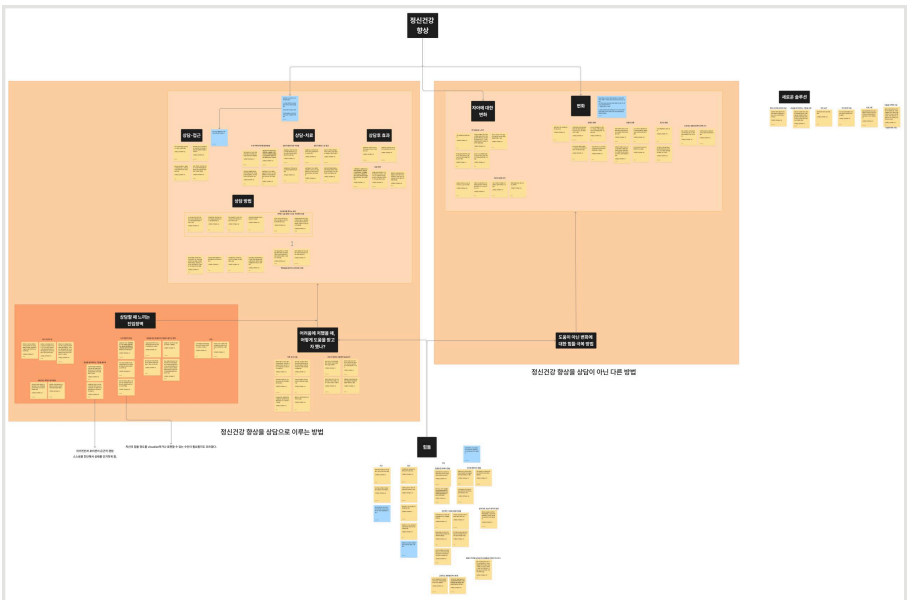
개발자 어피니티 최종



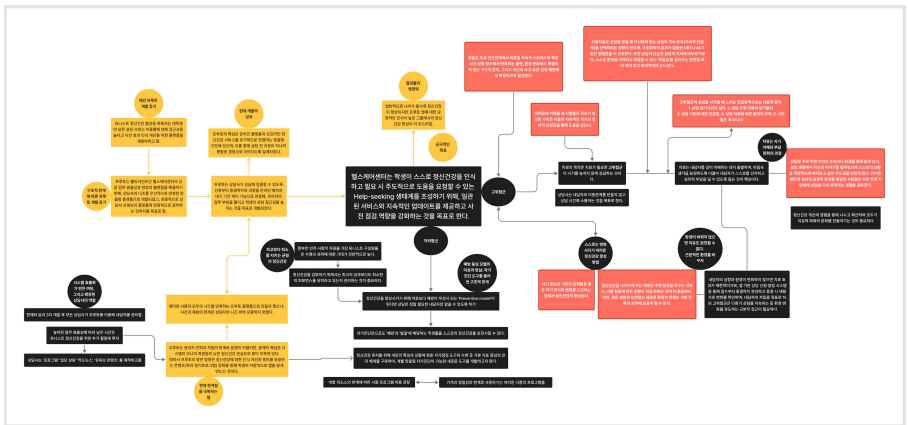
헬스케어 어피니티 최종



개발자 + 헬스케어 어피니티 통합



고위험군 어피니티



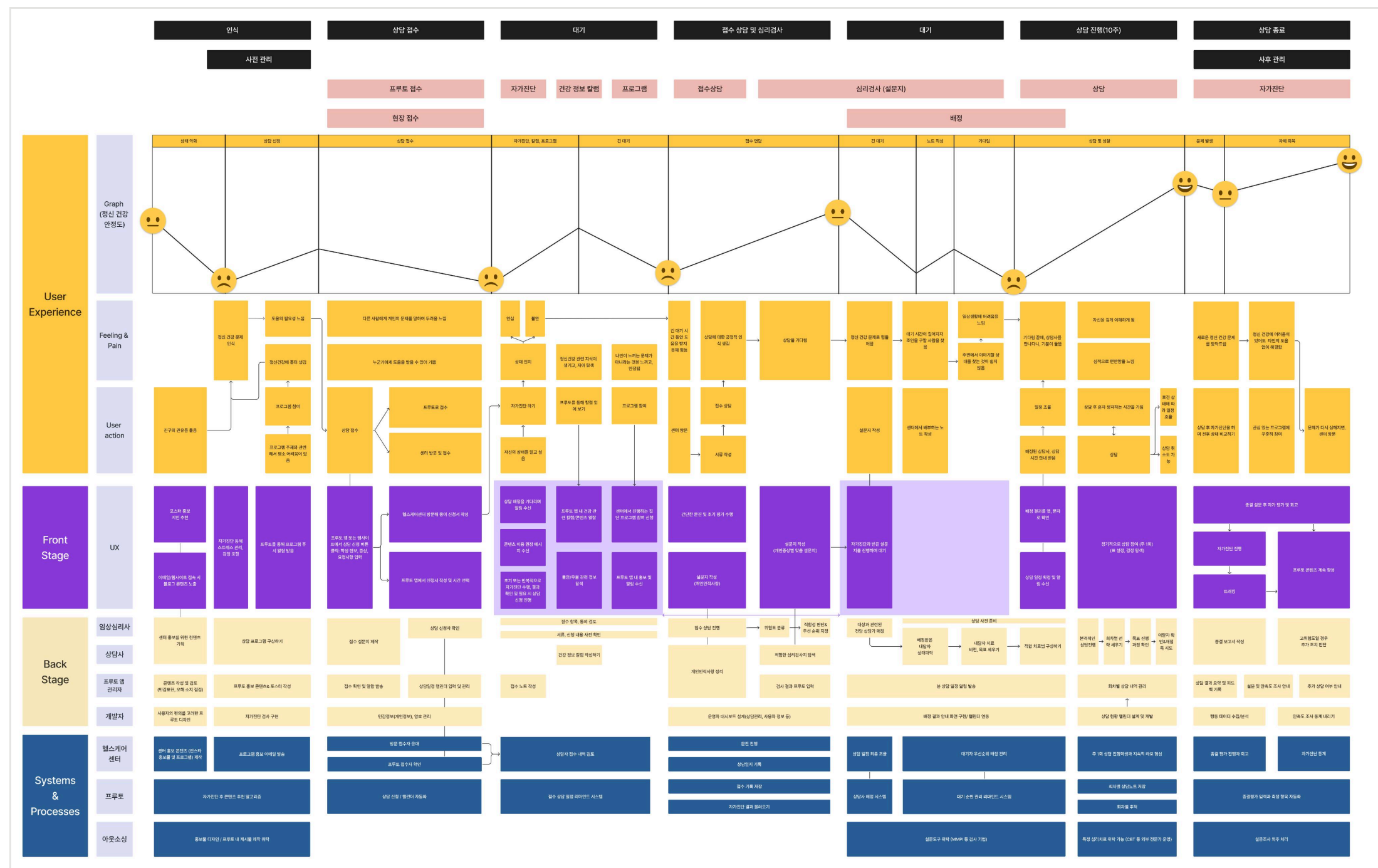
모든 이해관계자 어피니티 통합

+ 어피니티 다이어그램으로 인사이트를 정리하고자 Point 관점으로 분석, 유사한 것끼리 묶어서 상위 레벨로 요약 정리하고, 그 안에서 관계성을 찾아서 연결한 것까지 매우 훌륭했다.

- 다만, 아쉬운 것은 **관계성 정리가 좀 어색**했다. 관계성이 있는 거끼리 도식으로 정리하면 좋았을테지만 모든 것을 하나의 도식으로 정리하다보니 시각적이지 못했다.

- 또한 구조적으로 잘 쓰여진 글을 어느정도 남겼으나 글에 **불필요한 인사이트까지 섞여있다는 걸 발견**했고, 글을 더욱 구조적으로 쓰는걸 진행해야할 필요가 있다고 느꼈다.

서비스 블루프린트

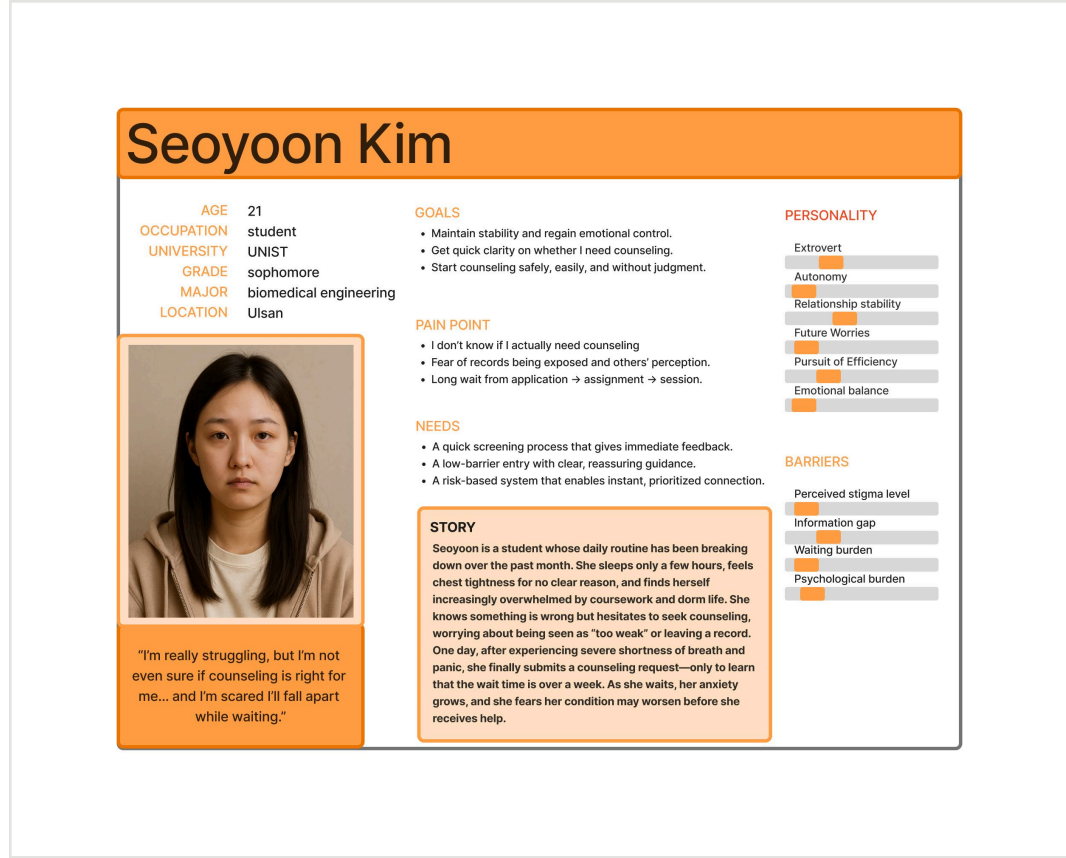


구체적인 서비스의 연결 지점들을 파악하는데에도 큰 도움이 되었다.

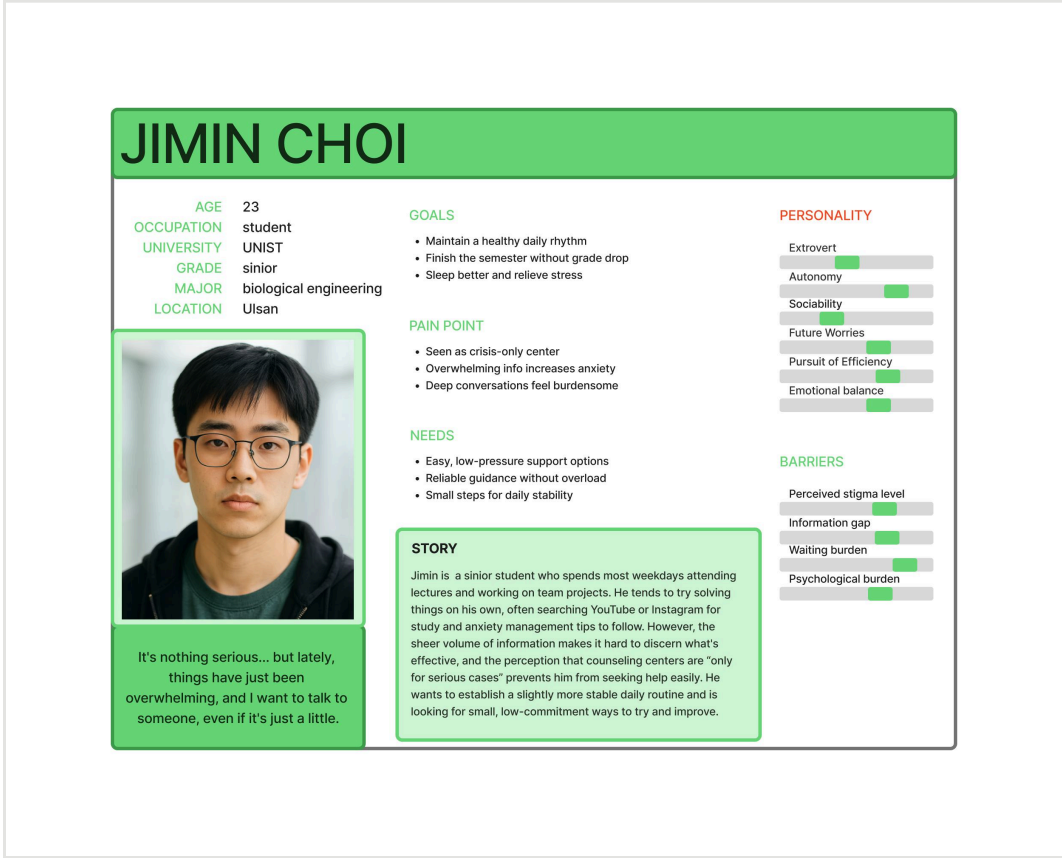
이를 통해 서비스의 어떤 병목지점이 있는지 문제정의와 함께 짚어보았다.

퍼소나

PRIMARY PERSONA



SECONDARY PERSONA



정신건강 서비스 재설계를 위해 위험도 기반 사용자 집단을 정의하였으며, 이 중 고위험군과 중·저위험군을 핵심 퍼소나로 설정하였다. Primary persona는 상담 접근 과정에서 구조적·심리적 장벽으로 인해 적절한 시점에 치료에 도달하지 못하는 고위험군이며, Secondary persona는 기능은 유지하고 있으나 지속적인 스트레스와 불안을 경험하는 중·저위험군으로 구성된다.

이 두 퍼소나는 서비스 재설계 방향을 구체화하는 데 중요한 기준으로 작용한다. Primary persona인 고위험군을 위해서는 상담 접근 과정의 심리적·구조적 장벽을 낮추고 빠르게 치료 단계에 연결하는 설계가 필요하며, Secondary persona인 중·저위험군을 위해서는 가벼운 개입을 기본값으로 제공하고 필요 시 상위 단계로 자연스럽게 이동할 수 있는 흐름을 마련해야 한다.

퍼소나 변수 정의

1. 위험도에 따라 고위험군과 일반군을 나누며
2. 자기 인식 능력으로 상담의 필요성을 인지하는 정도
3. 상담 회피 요인에 따라 이는 고위험군 인터뷰의 내용 일부를 참고했다.

문제정의 및 서비스 재디자인 방향성

문제 정의

고위험군

인터뷰와 어피니티 다이어그램 분석을 통해 드러난 **고위험군의 주요 문제는 상담을 이용하려는 초기 단계에서부터 여러 장벽을 경험한다는 점**이었다. **고위험군은 상담을 신청해도 대기시간이 지나치게 길어 접근이 어렵다고 말했고, 상담을 받아야 하는 기준 자체가 모호해 스스로 상담 필요 여부를 판단하기 어려웠다. 상담에 대한 정보 또한 정확하게 전달되지 않아 “상담받는 것에 대한 불이익을 걱정하는” 경우가 많았다.** 이들은 스스로 도움을 요청해야 할 타이밍을 놓치기 쉬운 구조 속에 있었기 때문에 상담의 관문 자체가 더 낮아질 필요가 있었다.

개발자와 헬스케어센터

정신건강 서비스에 참여하는 이해관계자들 역시 각기 다른 요구를 가지고 있었다. **개발자는 구성원의 정신건강 관심도를 높이고, 그 관심이 프루토를 통한 예방 활동으로 이어지기를** 기대하고 있었다.

반면 헬스케어센터 상담사들이 인식한 문제는 보다 구체적이고 운영에 밀접했다.

첫 번째로, 헬스케어센터는 “치료가 필요한 학생이 실제 상담 시기를 놓치지 않는 것”을 가장 중요한 목표로 두고 있었으나, 실제로는 고위험군이 적시에 상담에 도달하지 못하는 구조적 문제가 지속되고 있었다. 두 번째로, 학생들의 정신건강 정보를 제공하고 예방 활동을 확장하려는 의지는 있었지만, 실제 운영에서는 인력과 시간 부족이라는 제약으로 인해 이를 꾸준히 수행하기 어려웠다.

서비스 재디자인의 방향성

앞서 정리한 내용은 크게 네 가지 축의 문제로 정리되었다.

- 고위험군이 제때 치료 단계에 도달하지 못하는 구조
- 저·중위험군이 동일한 상담 흐름으로 유입되며 자원이 비효율적으로 사용되는 문제
- 상담에 대한 정보 부족과 낙인으로 인한 심리적 장벽
- 상담사 인력·시간 부족으로 인해 예방·정보 제공 활동이 지속되기 어려운 구조다.

우리는 이러한 문제들을 기반으로 HMW(How Might We) 방식의 질문으로 정리하였고, 이를 통해 이후 서비스 재설계를 위한 디자인 방향성을 도출하였다.

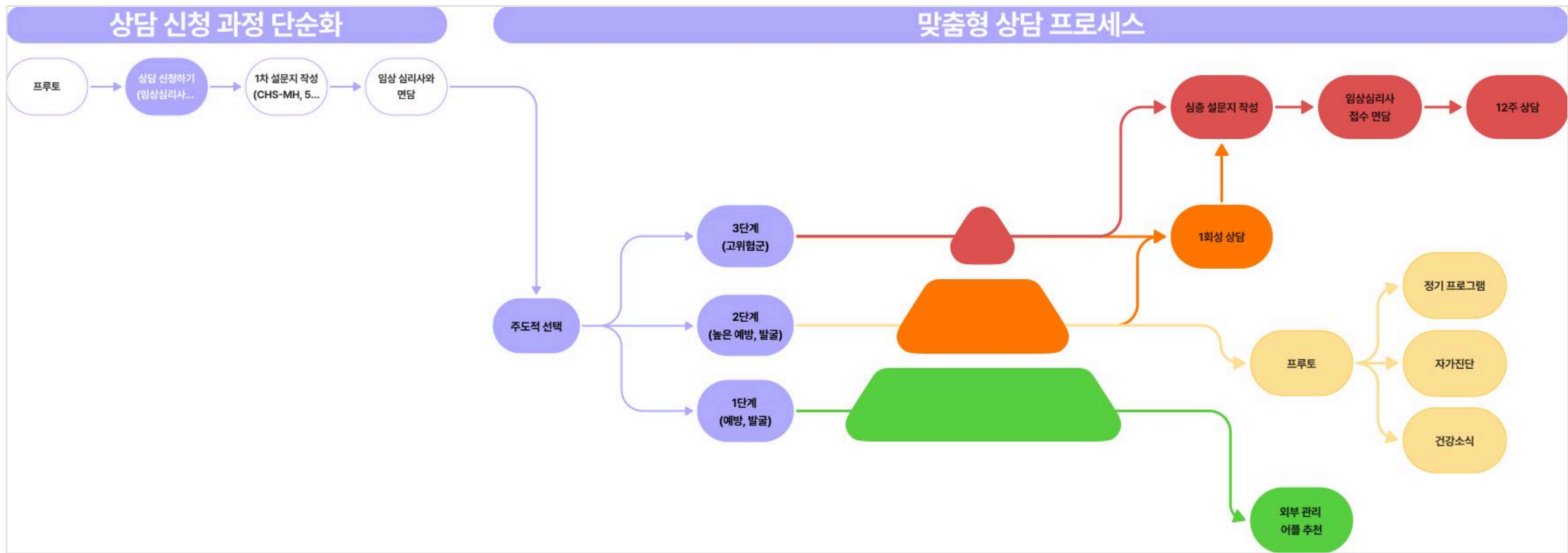
HMW 1 — 고위험군이 상담 서비스에서 대기하는 시간을 줄이려면?

HMW 2 — 저·중위험군이 ‘불필요한 상담’까지 가지 않게 하려면?

HMW 3 — 상담 진입의 심리적 장벽을 낮추려면?

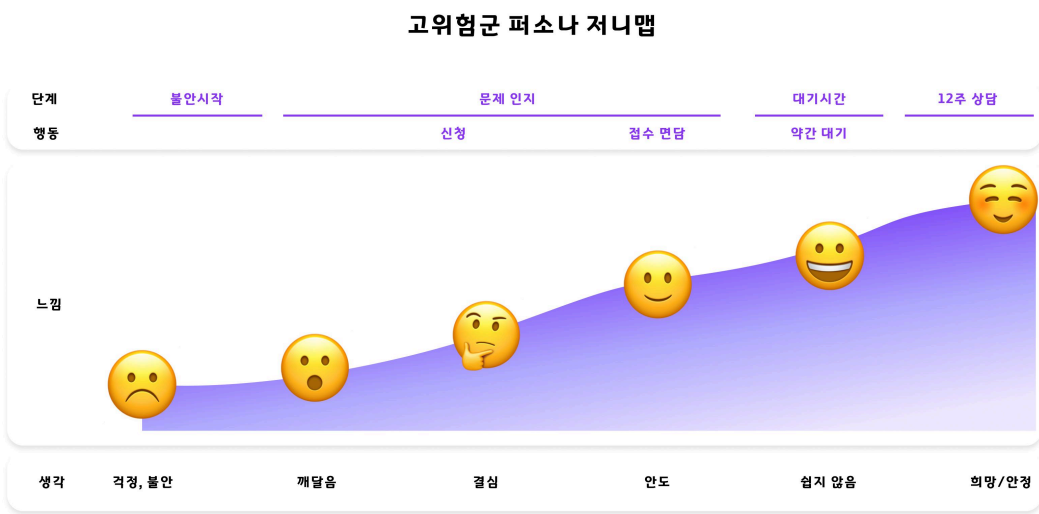
HMW 4 — 상담 정보 제공을 헬스케어센터의 리소스 부담 없이 지속 가능하게 하려면?

최종 솔루션



단계별 상담 구조 설계 근거

다양한 강도의 개입을 병행하는 단계적 접근인 ‘NHS의 IAPT 프로그램’, 캐나다 온타리오주의 여러 캠퍼스를 대상으로 한 Stepped Care 2.0 가이드를 참고하고, 유니스트 구조에 맞게 조합했다.



상담 신청 과정 단순화

새롭게 재디자인한 상담 서비스의 구조는 1차 설문을 먼저 진행하는 시스템을 도입하며 시작된다. 학생은 프루토를 통해 임상심리사와 예약을 먼저 잡은 후, CHS-MH 기반의 1차 설문지를 약 5분 동안 작성하게 되고, 이 결과는 임상심리사에게 전달된다. 임상심리사는 이 설문 결과를 먼저 확인하기 때문에 학생을 만나기 전에 이미 상태를 이해할 수 있으며, 예약시간에는 20분의 짧은 면담에서 설문 결과와 대화를 종합해 내담자는 자신의 현 상태를 한층 더 정확하게 파악하고 임상심리사와의 상담 후 **자신에게 적합한 치료 단계를 자발적으로 선택**한다.

맞춤형 상담 프로세스

첫 번째는 **예방과 초기 발굴 단계에** 해당하는 저위험군이다.

이들은 프루토를 통해 자신의 상태를 이해할 수 있는 맞춤형 정보를 제공받고, 필요에 따라 정신건강 관련 프로그램이나 콘텐츠를 활용해 일상에서 기본적인 자기 관리를 수행할 수 있다. 이 단계는 학생이 상담까지 가지 않더라도 자신의 상태를 안정적으로 유지하는 데 초점을 둔다.

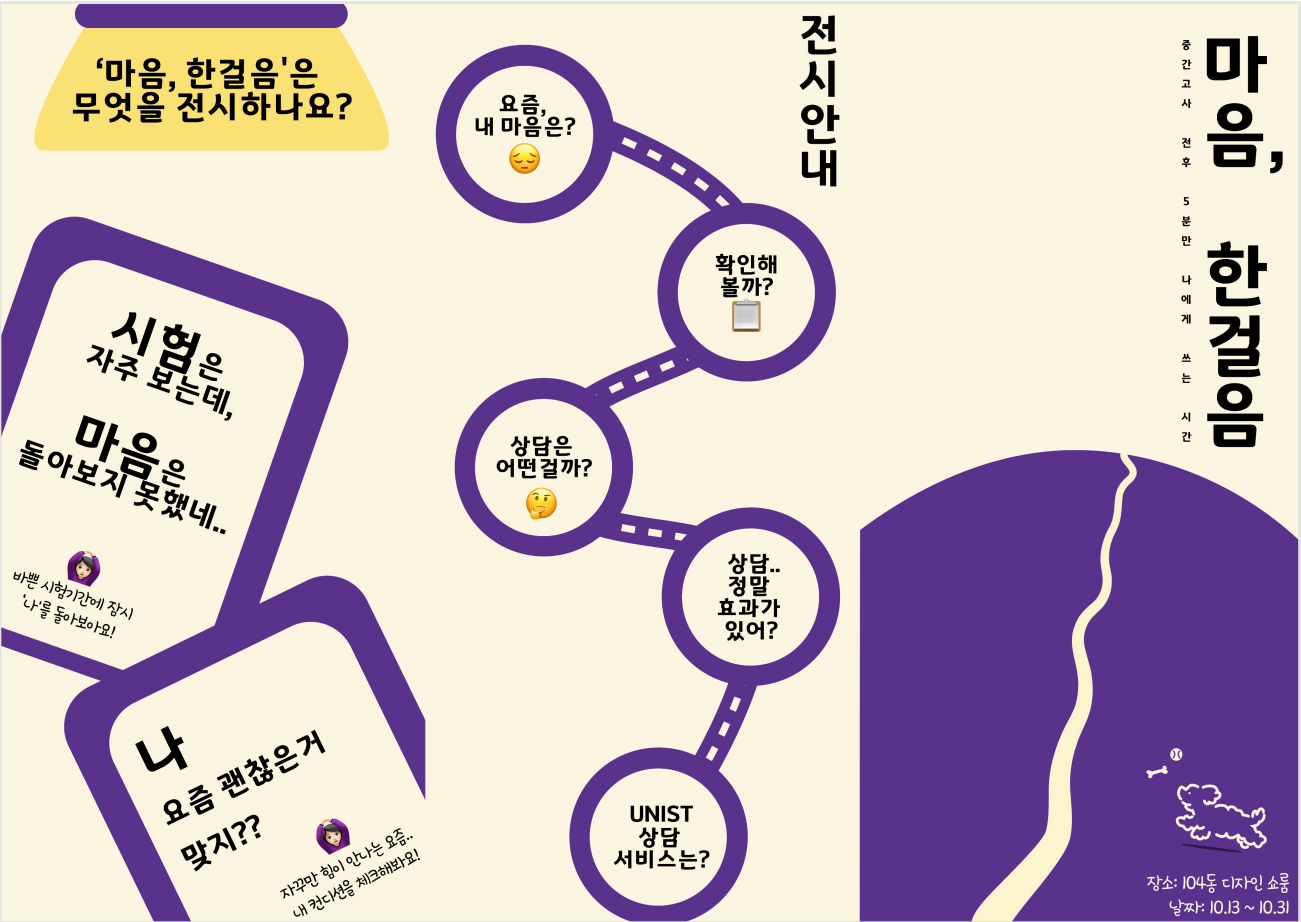
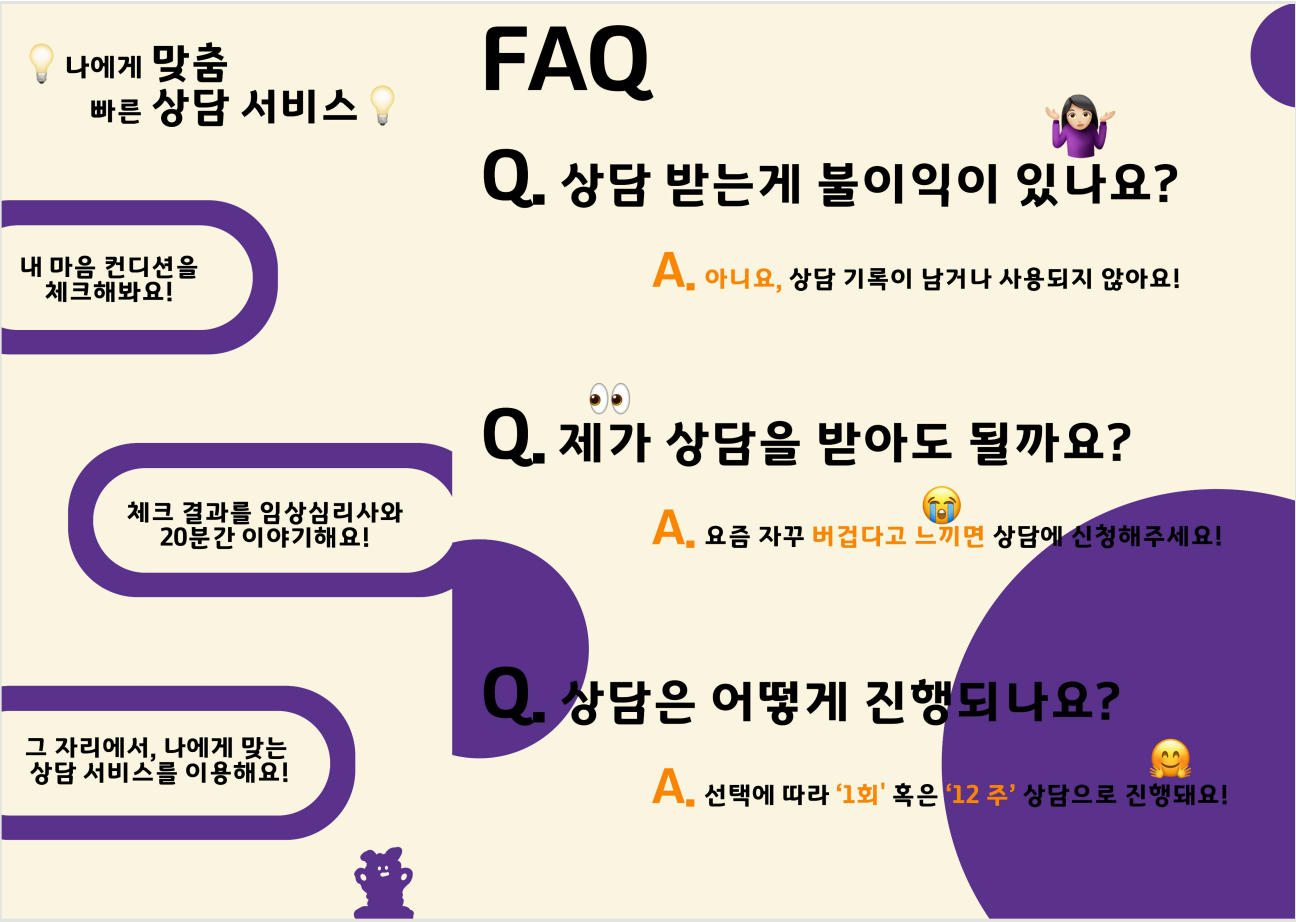
두 번째 단계는 **예방과 발굴의 상위 단계로**, 상담이 필요할 가능성이 있는 중·저위험군이다. 이들은 프루토의 기본 정보 제공 흐름에 더해 ‘**일회성 상담**’을 경험할 수 있다. 상담사는 하루에 3~4명, 일주일에 12명, 그리고 한 회차에 50~60분 정도를 진행하는데 이중에 일주일에 4회는 1회성 상담으로 운영하며 이 시간에 **상담사는 내담자가 스스로 회복이 가능한지, 혹은 추가적인 상담이 필요한지를 함께 판단하게 된다**. 내담자 **스스로 회복이 가능**하다고 판단되면 예방 차원의 비정기 상담을 이용하길 권장하여 위험 상태로 넘어가는 것을 방지하고, **스스로 회복이 어렵**다고 판단될 경우 12주간의 상담 치료로 자연스럽게 안내된다.

세 번째 단계는 **고위험군**이다. 임상심리사는 이 단계의 학생에게 상담을 받아야 하는 기준을 명확하게 설명하고, 12주간의 치료 상담을 권장한다. 다만 고위험군이라 하더라도 치료 기간에 대한 부담을 느낄 수 있기 때문에, 바로 12주에 들어가기보다 **일회성 상담을 먼저 경험해보고 결정할 수 있는 선택권을 유지**했다. 만약 12주 상담을 선택하게 되면 학생은 보다 심층적인 심리 설문지를 프루토를 통해 작성하고, 임상심리사의 접수 면담을 거쳐 심리상담사가 배정된다. 이후 12주간의 상담을 통해 상황을 개선하고 회복을 돕는 구조로 진행된다.

솔루션의 의의

단계별로 내담자를 나눠서, 내담자에게 알맞는 서비스를 제공해줌에 따라 고위험군의 대기시간이 줄어들어 진입에서의 장벽이 최소화될 것이다.

최종 솔루션



정신건강 전시회 기획

상담 접근에 대한 심리적 장벽을 낮추기 위해 정신건강 전시회를 솔루션을 구성했다. **많은 학생들이 상담에 대해 잘못된 정보나 막연한 불안감을 가지고 있었고, 상담의 실제 경험이나 절차에 대해 명확히 알 기회가 많지 않았다.** 전시회는 이러한 정보 격차를 해소하고 상담에 대한 사회적 낙인을 낮추기 위한 목적으로 설계되었다.

전시회에서는 **상담 절차와 기준에 대한 올바른 정보를 한눈에 볼 수 있도록** 구성하고, 학생들이 자주 묻는 질문들을 FAQ 형태로 제공하여 상담에 대한 오해를 줄일 수 있도록 했다. 또한 프루토에 기록된 상담 후기를 전시하거나 학생들이 현장에서 직접 포스트잇을 붙여 자신의 경험을 나누는 참여형 요소를 도입해 상담 문화가 자연스럽게 확산될 수 있도록 유도하는 활동을 만들었다. 상담을 시작하려면 프루토 설치가 필요하다는 것을 전시회에서 안내하여 학생들의 프루토 접근성을 높이도록 구상하였다.

터치포인트의 다양화

서비스 터치포인트 매트릭스 관점에서 보면, 재디자인된 구조는 기존보다 내담자가 거치는 전체 프로세스가 보다 구체화된 것을 확인할 수 있다. 각 단계에서 접하는 터치포인트가 다양해지면서, 내담자는 자신의 상태와 필요에 따라 더 알맞은 사용자 경험을 제공받을 수 있는 흐름으로 정리되었다.

기존의 터치포인트 매트릭스

	정신 상태를 파악하고자 함	정신 상태 인지	상태에 따른 치료 선택	상담 받기	지속적 관리
프루토					
임상 심리사					
심층 설문조사					
12주 상담					



기존의 터치포인트 매트릭스

	정신 상태를 파악하고자 함	정신 상태 인지	상태에 따른 치료 선택	상담 받기	지속적 관리
프루토					
외부 어플					
임상 심리사					
1차 설문조사					
심층 설문조사					
12주 상담					
일회성 상담					
전시회					

최종 솔루션 코멘트

잘한 점

[프로세스] 촘촘하고 치밀하게 했다. 인터뷰 전사 → 의미 단위로 분절 → 포스트잇으로 옮김

[분석] 비슷한 것끼리 묶어 인사이트를 뽑으면 그 요약 안에 인과 문장이 생긴다. 무엇이 원인이고 무엇이 결과인지, 무엇이 산출물인지, 어떤 집합 관계가 있는지를 파악했다.

[통합] 여러 개의 어피니티를 하나로 묶어, 이해관계자들 간의 충돌이 어디서 어떻게 일어나는지를 도출했다.

[결과] 문제 정의까지 잘 도달했다.

아쉬운 점

① 검증할 수 없었다

인력·자원은 그대로 두고 서비스 구조만 바꿔서 서비스가 더 원활히 돌아가게 하는 솔루션이었다. 그런데 그게 실제로 그렇게 되는지 검증하기 어려운 부분이 있었다. 상상에 기댄 부분이 남아 있다.

② 기존 서비스와의 직접 비교가 없다

기존 대비 무엇이 어떻게 바뀌는지에 대한 구체적 시나리오가 들어가지 않아 헛갈릴 만했다.

새로 설계한 구조도가 어떤 효과가 있는지를 블루프린트 측면에서 **As-is / To-be**로 나란히 보여줬어야 하는데 그게 안 됐다.

③ 아이디어션 연결이 어려웠다

문제 정의는 잘 됐다. 그런데 그 문제를 어떤 컴포넌트 단위로 풀지, 서비스 구조를 어떻게 바꿀지로 넘어가는 게 어려웠다. UX 전략, 디자인 기능, 디자인 컴포넌트 단위로 UI나 제품을 제작하는 것이 아니라 서비스 구조를 개선하는 것이었기에 더욱 그랬다.

④ 해결책이 최선인지 모른다

전시회가 있으면 좋겠다는 판단은 맞다. 그런데 누가, 어떻게 운영하는가가 여전히 모호하다. 구체적인 전시회 운영 기획까지 정리했다면, 실현 가능한 솔루션으로 보였을 것이다.

교수님 코멘트

Councy

방대한 양의 리서치, 그리고 고위험군 학생들을 인터뷰하겠다는 과감한 선택이 인상적이었습니다. 추가로 제출한 리포트에 그 점이 잘 드러나 있었습니다!

프로세스 서술도 좋았습니다. 특히 고위험군 그래프는 정확히 핵심을 짚었는데, 다만 출처(학술 자료나 언론 보도)가 함께 제시되었다면 더 좋았을 것입니다.

실무적인 조언 하나 — 발표를 진행하는 도중에 리포트나 인쇄물을 배포하는 것은 일반적으로 좋은 방법이 아닙니다. 청중이 발표에 집중하지 않고 자료를 읽기 시작하는 경향이 있기 때문입니다. 다음번에는 발표를 모두 마친 뒤에 인쇄물을 나눠주세요.

더 중요한 문제는 제안(proposal)의 구체성이 부족했다는 점입니다. 그 전시가 실제 현실에서 어떻게 작동하는지, 그래서 정신건강 서비스의 개선에 어떻게 기여하는지가 충분히 명확하지 않았습니다. 이 점은 발표 이후 청중 한 분에게서 받은 이메일 피드백에도 그대로 반영되어 있습니다:

"정신건강이라는 복잡하고 민감한 주제를 다루기로 한 팀의 결정은 특히 높이 평가할 만했고, 기존 서비스와 이해관계자 관점에 대한 조사의 깊이 또한 그러했습니다. 다만 최종 발표에서는 제안된 솔루션의 핵심 아이디어와 구체적인 가치 제안(value proposition)을 명확히 파악하기가 다소 어려웠습니다. 프로젝트가 위기 수준(crisis-level) 기반의 상담 프로세스와 전시 요소를 중심으로 구성된 것으로 보였습니다만, 그 구체적인 작동 기제와 기존 모델과의 차별점이 항상 분명하게 드러나지는 않았습니다.

특히 상담 프로세스는 이미 대학 상담센터에서 일반적으로 시행되고 있는 단계적 개입(steppped-care) 접근과 상당히 유사해 보였습니다. 실무의 관점에서 이 분야의 가장 고질적인 과제로는 초기 단계에서 위험도를 정확히 평가하는 일, 역동적으로 변화하는 위험 수준에 대응하는 일, 그리고 상담 프로세스의 효과성과 효율성을 정량적으로 평가하는 일 등이 꼽힙니다. 제안이 이러한 미해결 과제들을 어떻게 다루는지, 혹은 어떤 차별화된 관점을 제시하는지가 좀 더 분명하게 설명되었다면 발표가 한층 더 설득력을 가졌을 것입니다.

이 의견은 건설적인 취지에서 드리는 것입니다. 정신건강 서비스는 다수의 이해관계자와 상당한 제도적 제약이 얽혀 있어, 제한된 기간 안에 프로토타이핑하거나 검증하기가 어렵습니다. 이에 비해 일부 다른 팀들은 더 작은 규모에서 작업하며, 즉각적으로 이해 가능하고 구체적인 프로토타입을 통해 아이디어를 제시했습니다. Councy 팀의 경우, 분석의 깊이와 엄밀함은 분명한 강점이었으나, 그것이 의도치 않게 일종의 '분석 마비(analysis paralysis)'로 이어져, 문제 공간에 대한 폭넓은 이해가 오히려 더 사변적이거나 탐색적인 디자인 시도의 여지를 제약했을 가능성이 있습니다. 이는 디자인 및 연구 실무에서 빈번하게 마주치는 어려움입니다. 그럼에도 이 프로젝트는 상당한 배움과 성장을 분명히 보여주며, 앞으로의 작업이 더욱 발전해 나가기를 바라는 마음에서 이러한 생각을 공유합니다."

그럼에도 이번 프로젝트는 여러분이 이 문제를 얼마나 깊이 아끼고 있는지, 그리고 깊이 있는 리서치를 통해 상황을 나아지게 하고자 하는 마음을 잘 보여주었습니다. 수고 많았습니다!